Pathologies des glandes annexes - foie, voies biliaires, pancréas

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

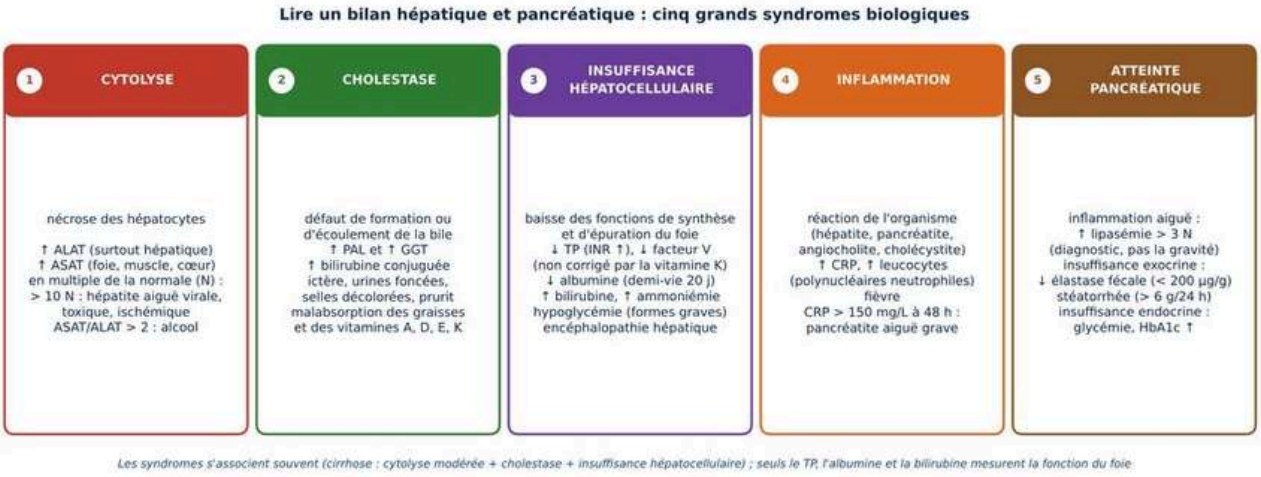


Figure 33.1 – Les cinq syndromes biologiques des maladies du foie et du pancréas : cytolyse, cholestase, insuffisance hépatocellulaire, inflammation, atteinte pancréatique (33.3.1)



Figure 33.2 – Les trois mécanismes de l'ictère : excès de bilirubine libre, cholestase intrahépatique, cholestase extrahépatique (obstacle) (33.3.1)

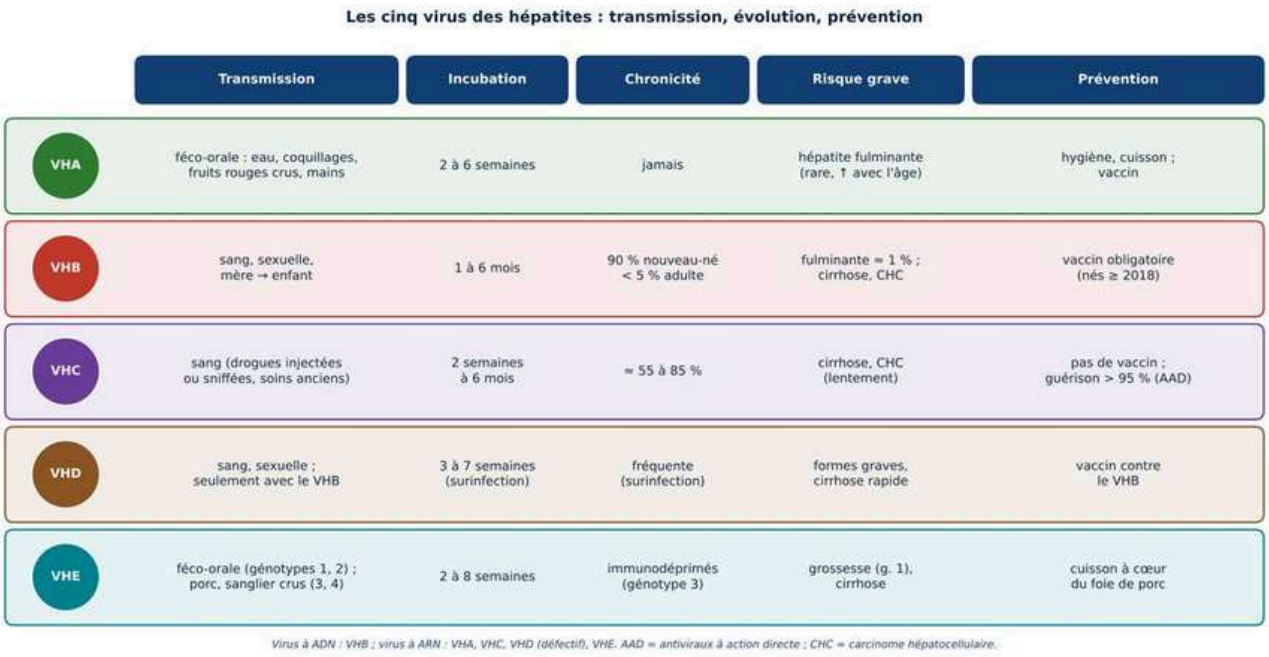


Figure 33.3 – Les virus des hépatites A à E : génome, transmission, incubation, passage à la chronicité, prévention et traitement (33.3.1)

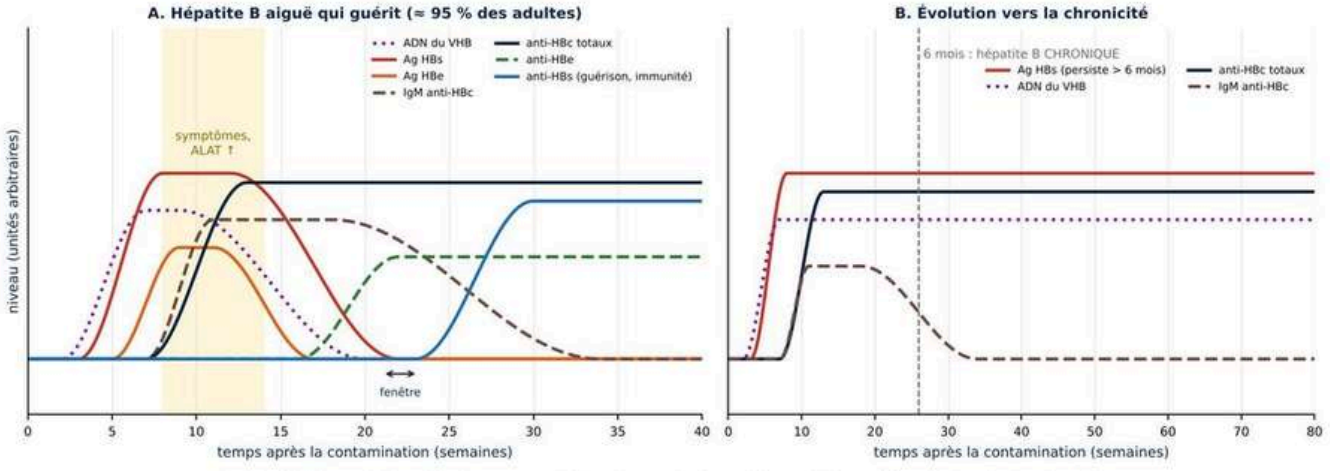


Figure 33.4 – Marqueurs sérologiques de l'hépatite B : profil d'une hépatite aiguë qui guérit (A) et d'une évolution vers la chronicité (B), schéma (33.3.1)

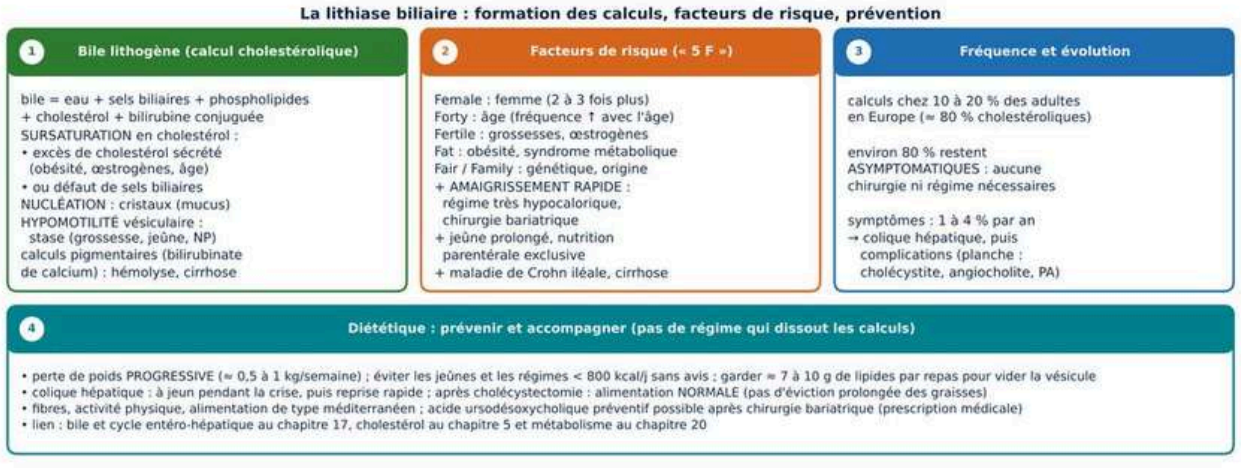


Figure 33.5 – La lithiase biliaire : bile lithogène, facteurs de risque, fréquence et évolution, conseils diététiques (33.3.1)

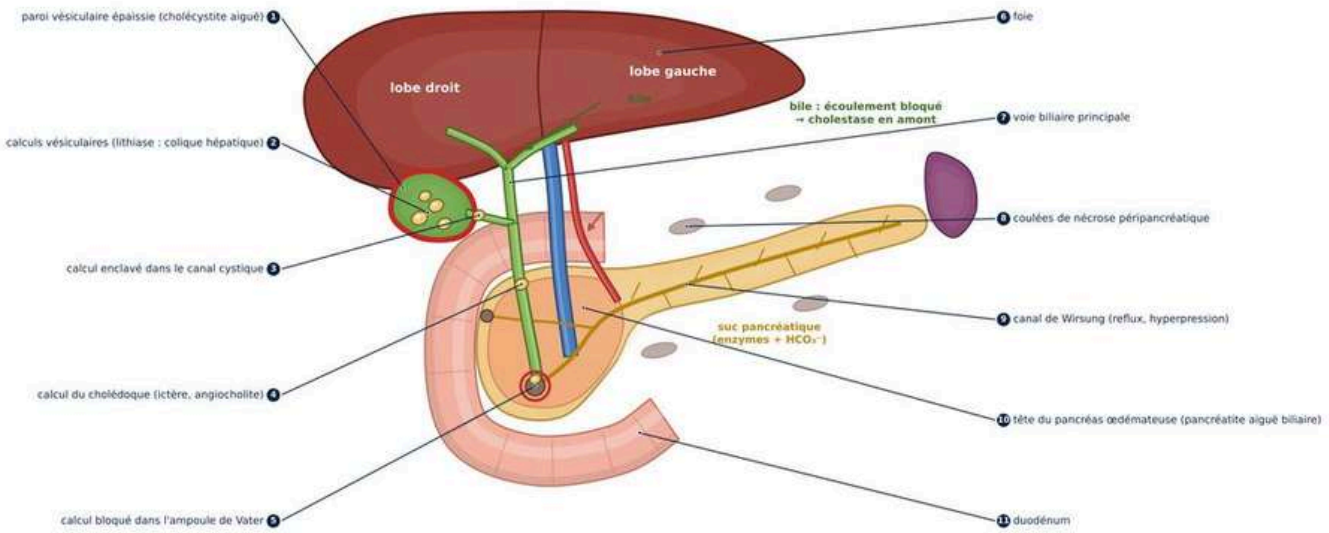


Planche – la lithiase biliaire et ses complications : du calcul vésiculaire à la pancréatite aiguë biliaire (vue antérieure, foie relevé)

Figure 33.6 – Planche – la lithiase biliaire et ses complications : du calcul vésiculaire à la pancréatite aiguë biliaire (vue antérieure, foie relevé) (33.3.1)

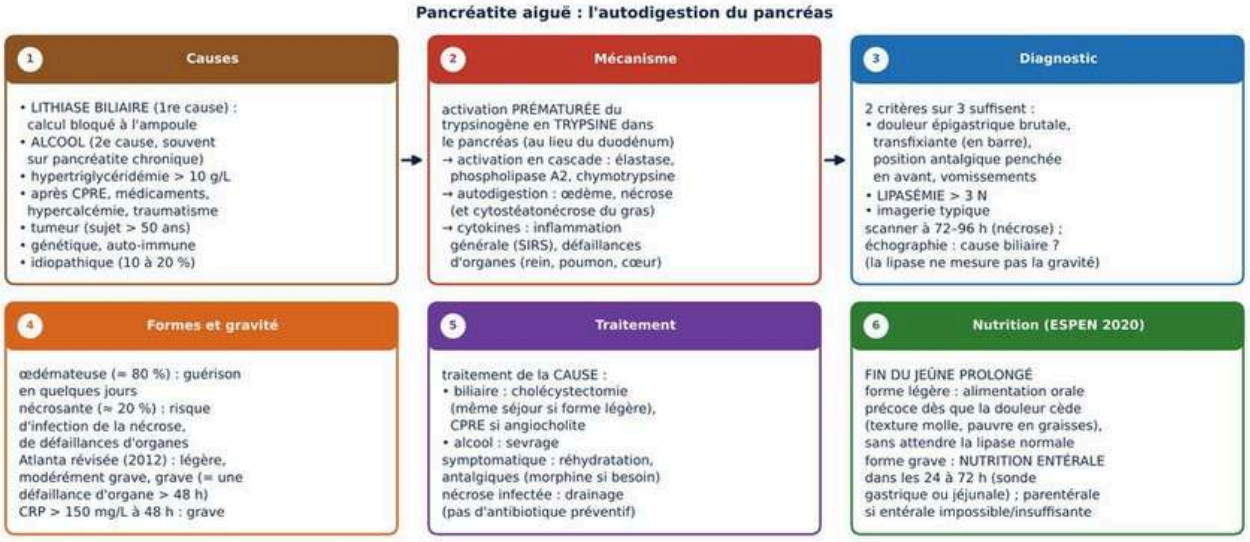
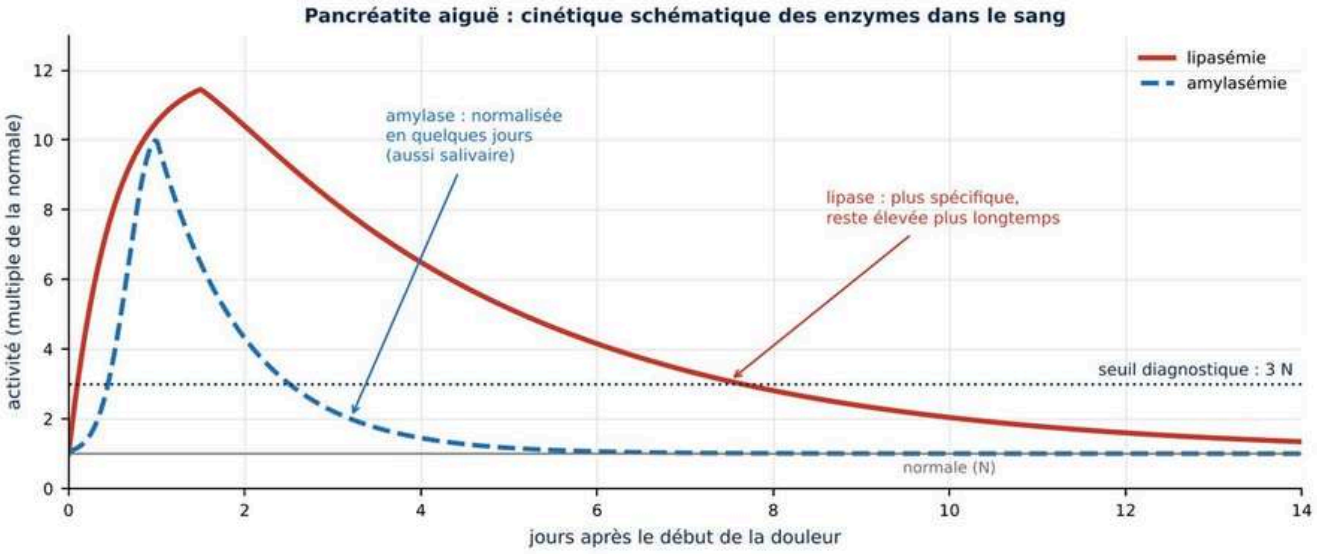


Figure 33.7 – La pancréatite aiguë : causes, mécanisme d'autodigestion, diagnostic, gravité, traitement et nutrition (33.3.1)



Le taux de lipase n'est PAS corrélé à la gravité : la gravité se juge sur la clinique, la CRP et les défaillances d'organes (schéma, valeurs illustratives)

Figure 33.8 – Cinétique schématique de la lipasémie et de l'amylasémie au cours d'une pancréatite aiguë : la lipase, plus spécifique, reste élevée plus longtemps (33.3.1)

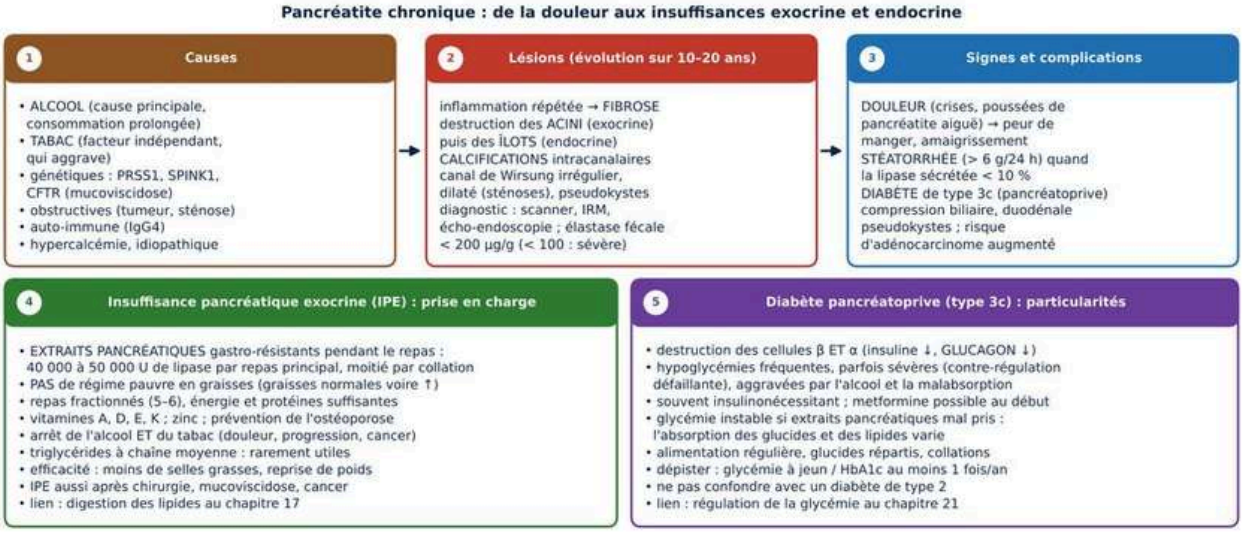
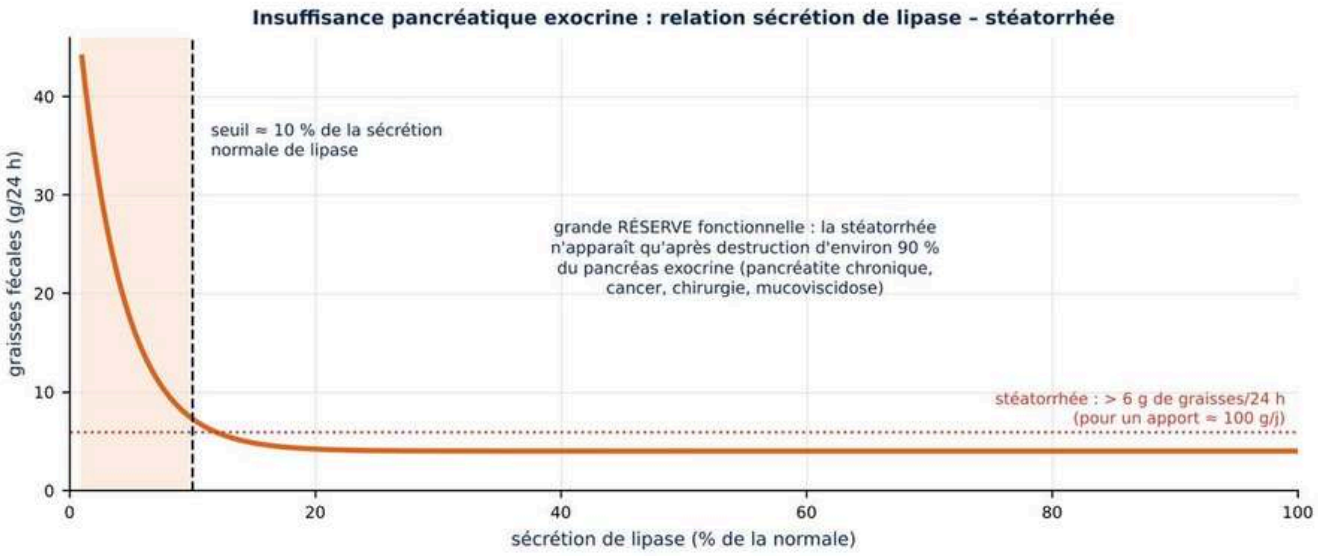


Figure 33.9 – La pancréatite chronique : causes, lésions, signes et complications ; prise en charge de l'insuffisance exocrine et du diabète pancréatoprive (33.3.1)



Courbe schématique d'après les travaux de DiMagno et al. (N Engl J Med, 1973) ; élastase fécale < 200 µg/g : IPE probable, < 100 µg/g : IPE sévère

Figure 33.10 – Relation schématique entre la sécrétion de lipase et l'excrétion fécale des graisses : la stéatorrhée n'apparaît que sous 10 % de sécrétion résiduelle (33.3.1)

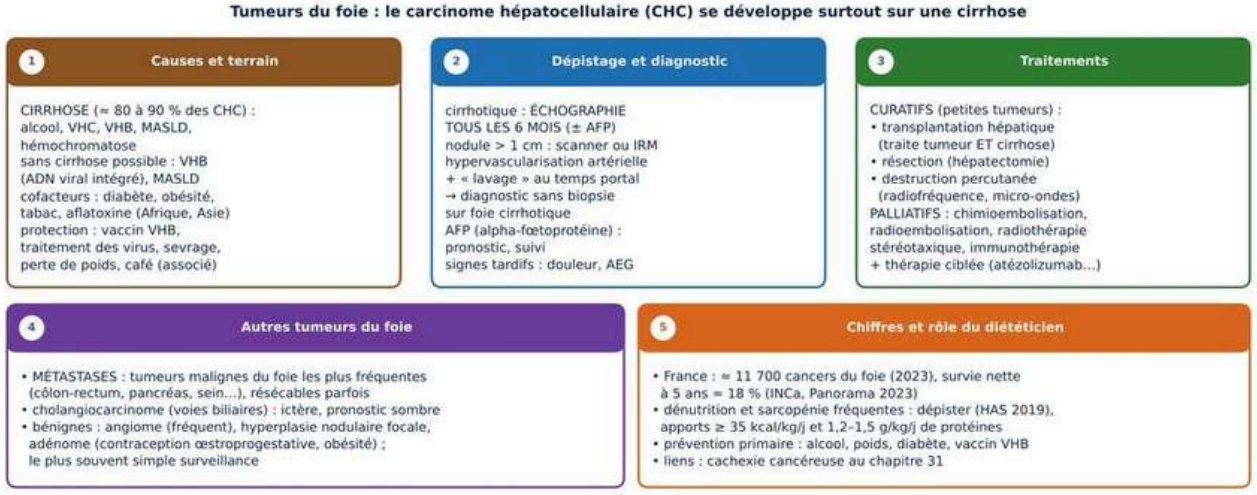


Figure 33.11 – Les tumeurs du foie : causes, dépistage, diagnostic et traitements du carcinome hépatocellulaire ; autres tumeurs ; chiffres et rôle du diététicien (33.3.2)

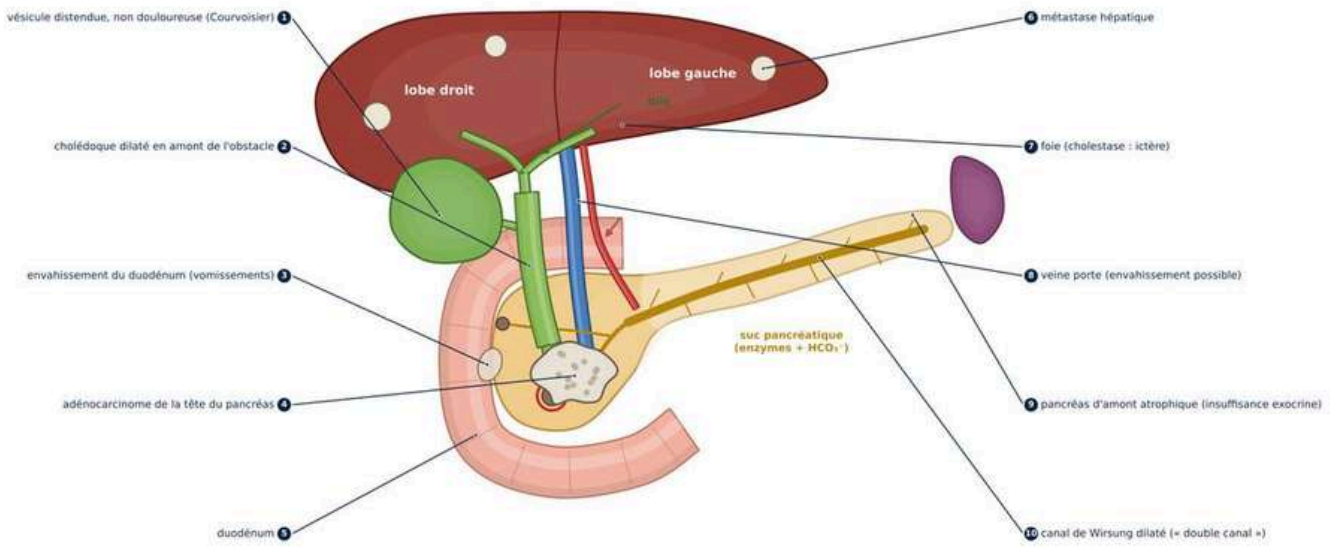


Planche - l'adénocarcinome de la tête du pancréas : obstacle sur la voie biliaire principale et le canal de Wirsung (vue antérieure, foie relevé)

Figure 33.12 – Planche – l'adénocarcinome de la tête du pancréas : obstacle sur la voie biliaire principale et le canal de Wirsung (vue antérieure, foie relevé) (33.3.2)

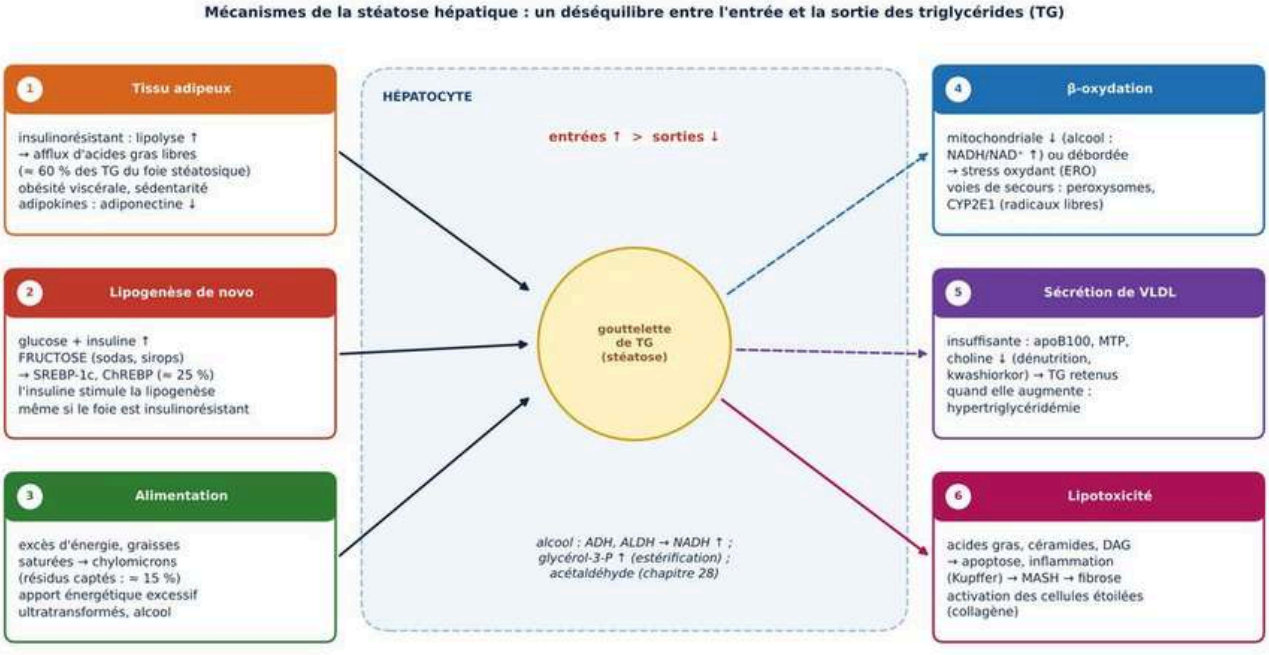


Figure 33.13 – Les mécanismes de la stéatose hépatique : entrées d'acides gras augmentées (tissu adipeux, lipogenèse, alimentation), sorties diminuées (β-oxydation, VLDL) et lipotoxicité (33.3.3)

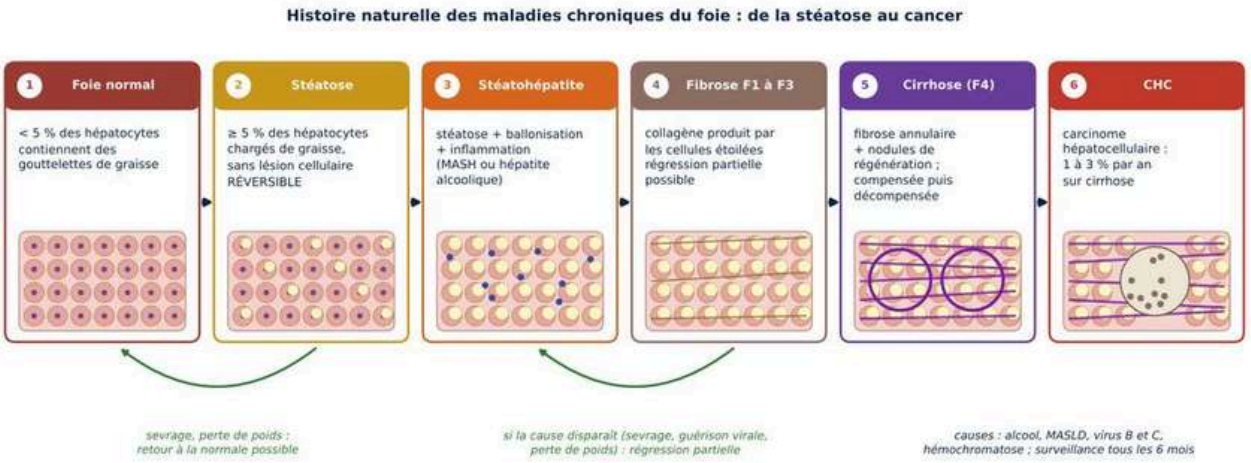


Figure 33.14 – Histoire naturelle des maladies chroniques du foie : de la stéatose réversible à la cirrhose et au carcinome hépatocellulaire (33.3.3)

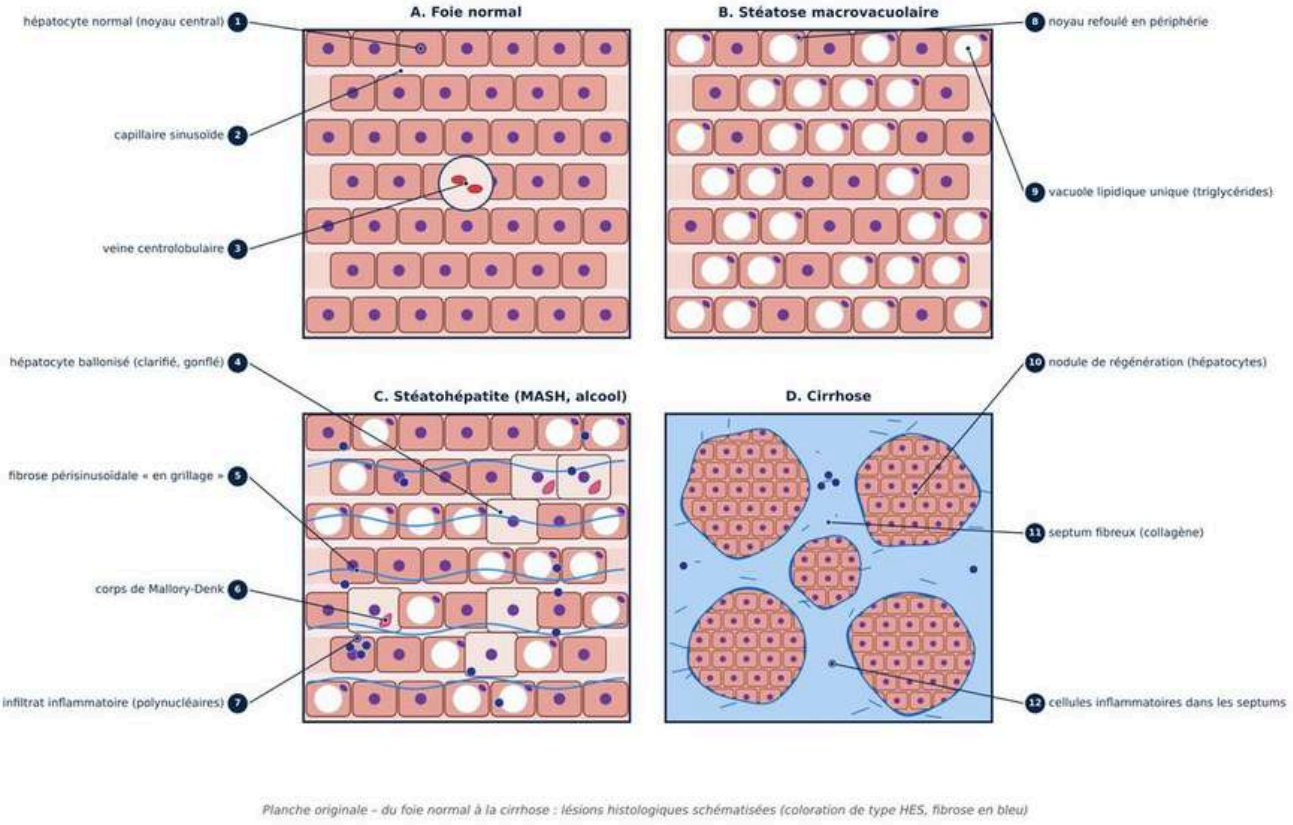


Figure 33.15 – Planche – du foie normal à la cirrhose : lésions histologiques schématisées (A foie normal, B stéatose, C stéatohépatite, D cirrhose) (33.3.3)



Figure 33.16 – La cirrhose et ses conséquences : insuffisance hépatocellulaire et hypertension portale, sources de toutes les complications (33.3.3)

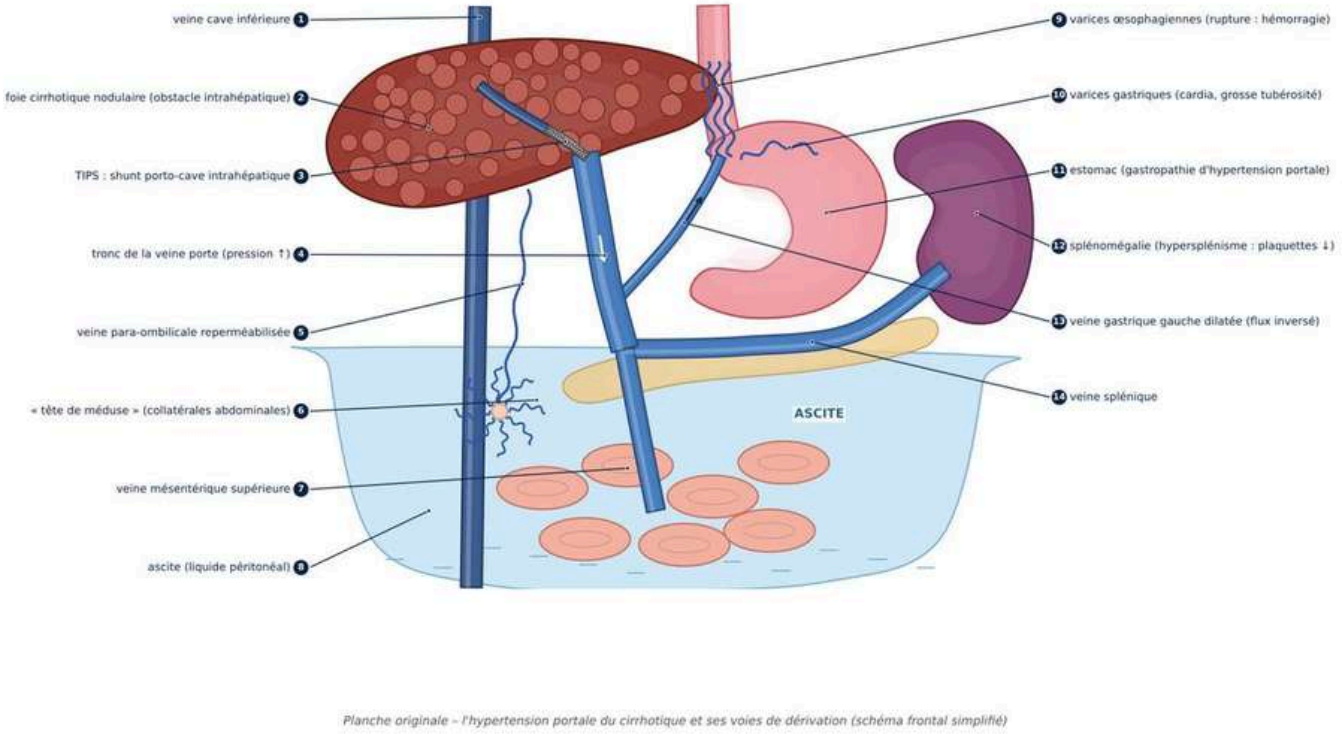


Planche originale – l'hypertension portale du cirrhotique et ses voies de dérivation (schéma frontal simplifié)

Figure 33.17 – Planche – l'hypertension portale du cirrhotique et ses voies de dérivation (schéma frontal simplifié) (33.3.3)

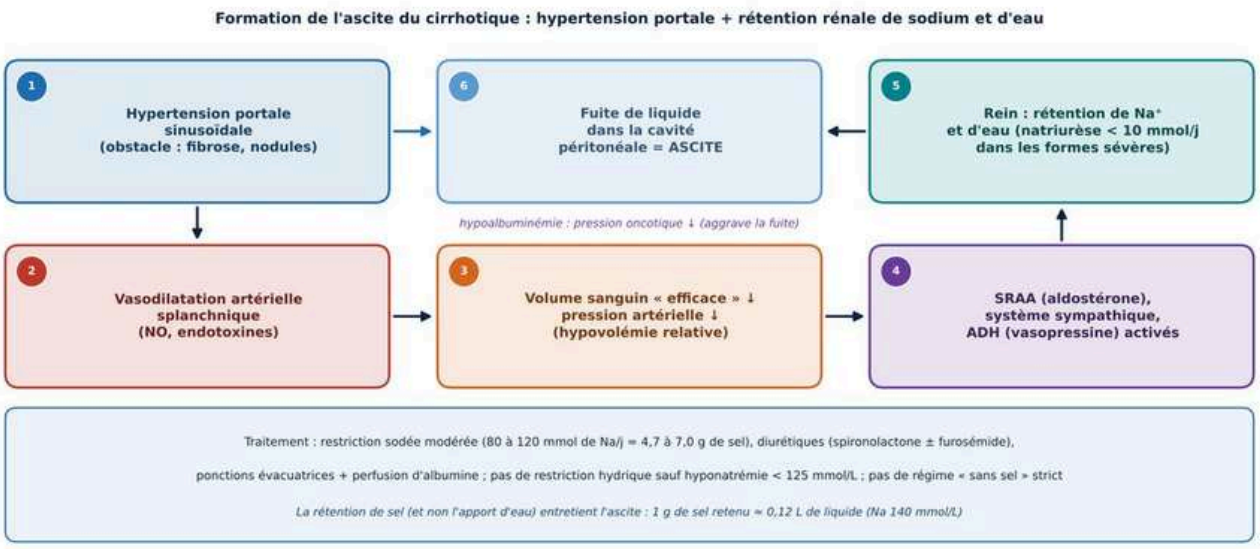


Figure 33.18 – Formation de l'ascite du cirrhotique : hypertension portale, vasodilatation splanchnique, hypovolémie « efficace », activation des systèmes de rétention sodée (33.3.3)

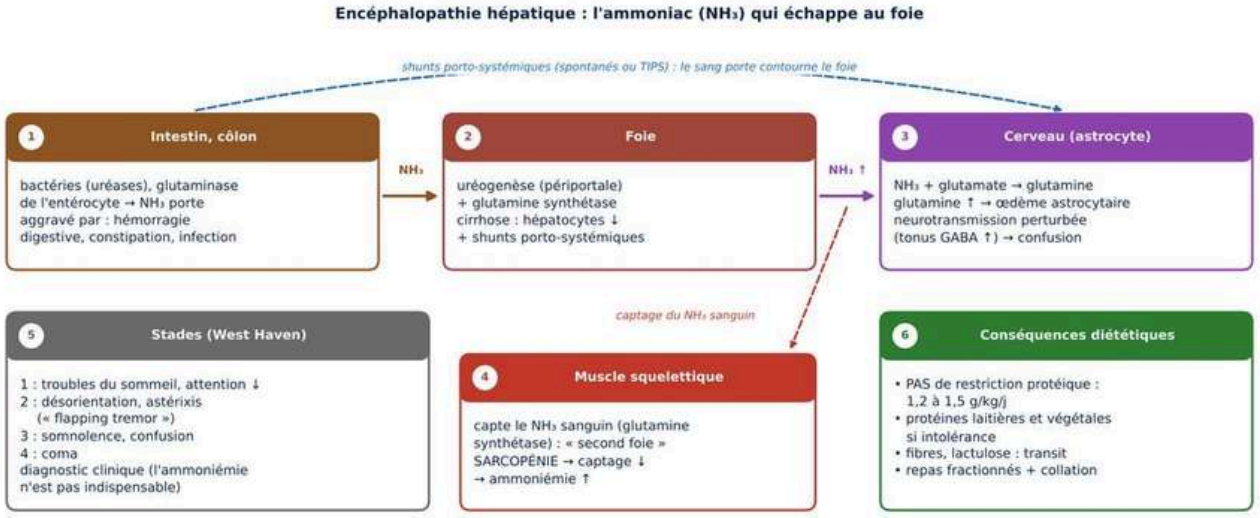


Figure 33.19 – L'encéphalopathie hépatique : l'ammoniac d'origine intestinale échappe au foie (insuffisance hépatocellulaire et shunts) et au muscle (sarcopénie) et atteint le cerveau (33.3.3)

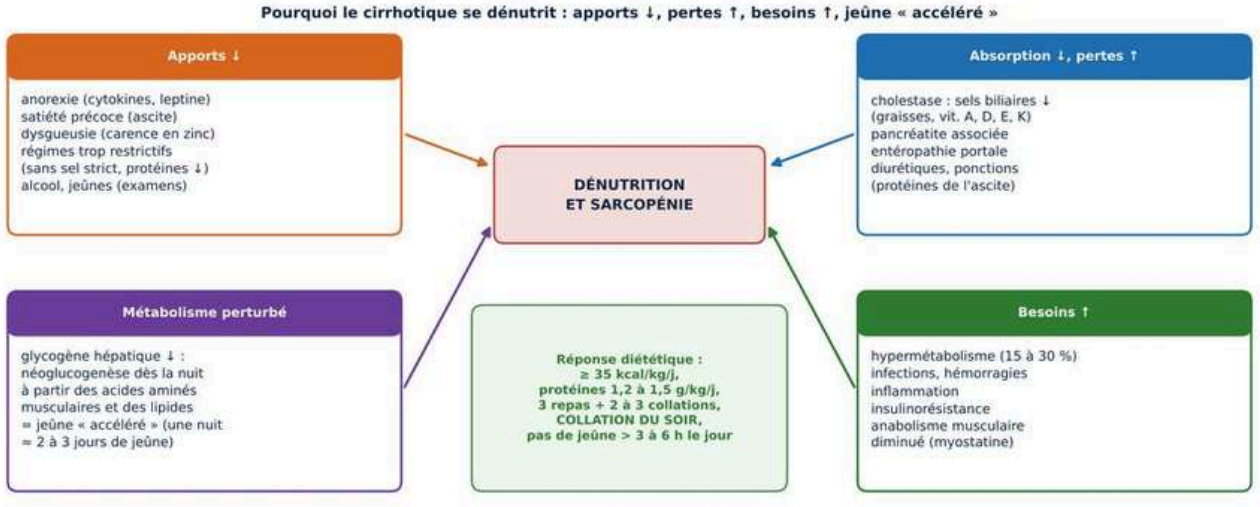


Figure 33.20 – Pourquoi le cirrhotique se dénutrit : apports réduits, malabsorption et pertes, métabolisme de jeûne accéléré, besoins augmentés (33.3.3)

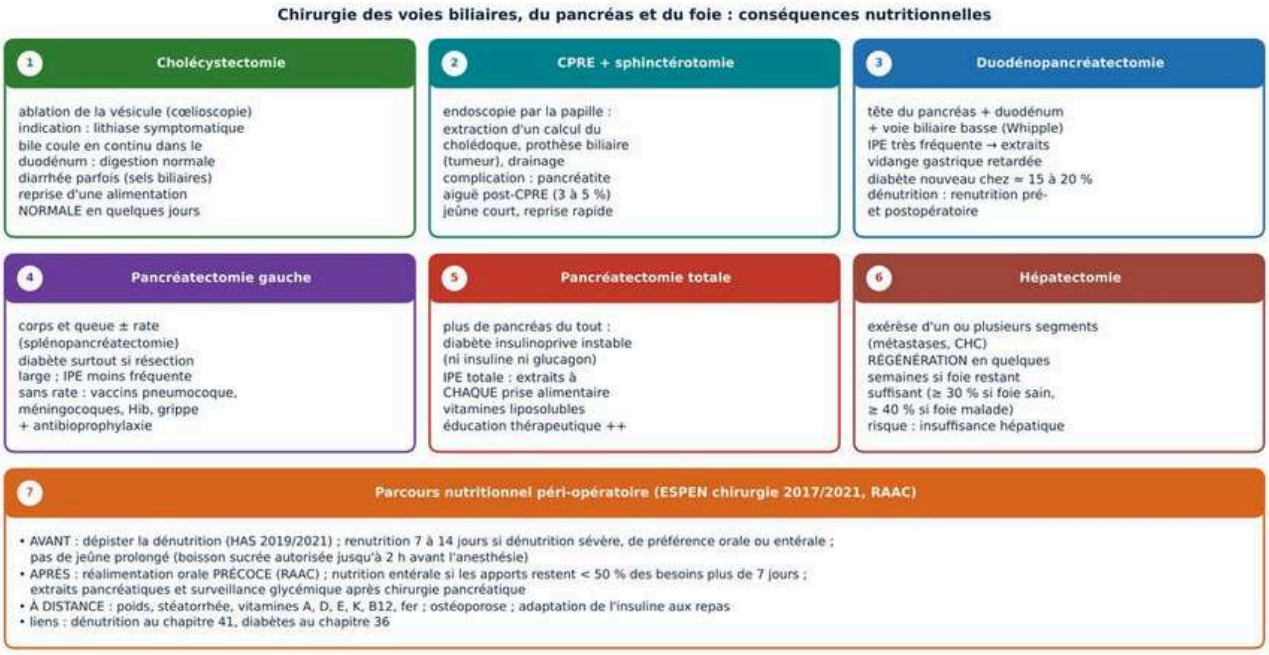


Figure 33.21 – Les principales interventions sur les voies biliaires, le pancréas et le foie et leurs conséquences nutritionnelles, avec le parcours péri-opératoire (ESPEN chirurgie 2017 et 2021, réhabilitation améliorée après chirurgie) (33.3.4)

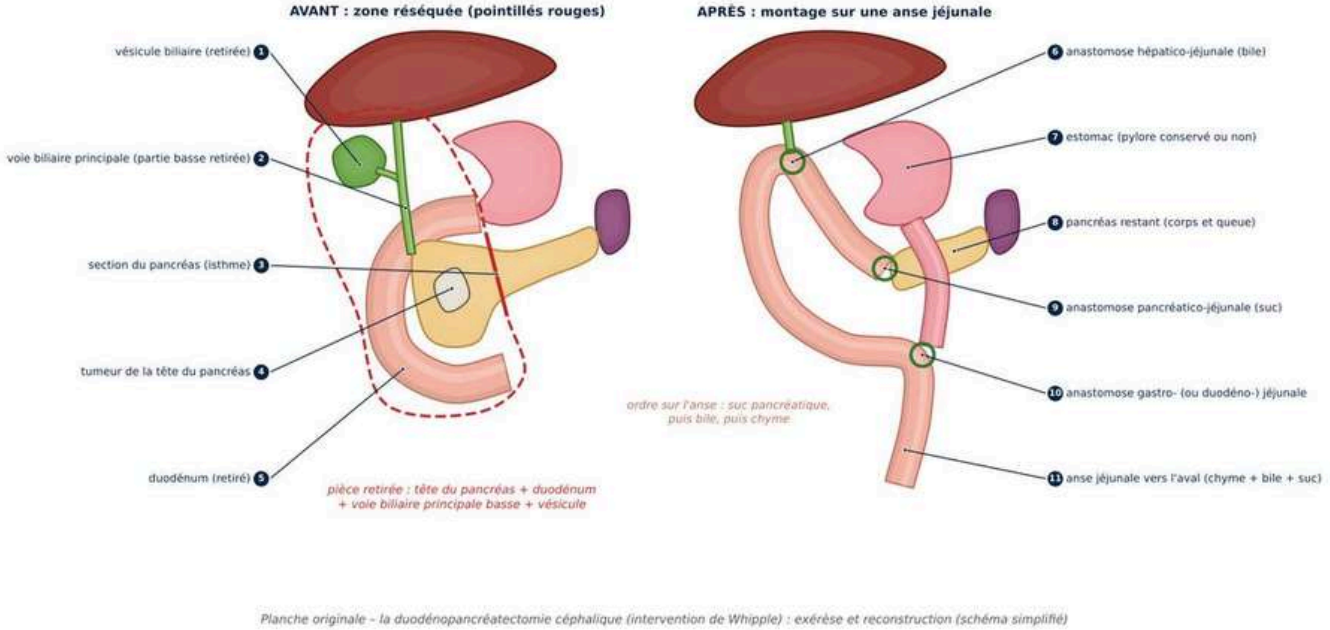


Planche originale – la duodénopancréatectomie céphalique (intervention de Whipple) : exérèse et reconstruction (schéma simplifié)

Figure 33.22 – La duodénopancréatectomie céphalique (intervention de Whipple) : pièce retirée (à gauche) et reconstruction sur une anse jéjunale (à droite) (33.3.4)

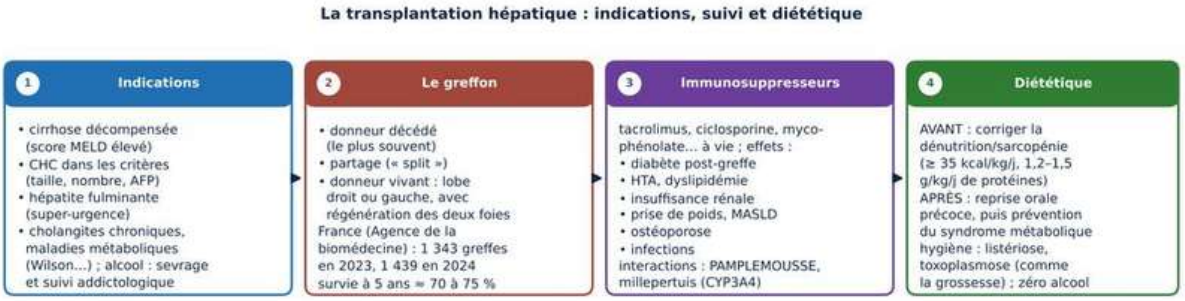


Figure 33.23 – La transplantation hépatique : indications, origine du greffon, traitements immunosuppresseurs et prise en charge diététique avant et après la greffe (33.3.4)